

Psychologisch Rapport

Cliënt: John Doe

Datum: 28 juni 2024

Psycholoog: Mark Jansen

Inleiding

Dit rapport betreft de psychologische evaluatie van John Doe, een 35-jarige man, verwezen voor evaluatie in verband met aanhoudende stemmingsproblemen en stressgerelateerde klachten. De evaluatie is uitgevoerd op basis van een combinatie van klinische interviews, gestandaardiseerde psychologische tests en zelfrapportagevragenlijsten.

Achtergrondinformatie

John Doe is een getrouwde man en vader van twee kinderen. Hij werkt als software-ontwikkelaar bij een groot technologiebedrijf. John rapporteert een geschiedenis van stemmingswisselingen en verhoogde stressniveaus, vooral gerelateerd aan werkdruk en familiale verantwoordelijkheden.

Huidige Klachten

John klaagt over de volgende symptomen:

- Chronische vermoeidheid
- Slaapproblemen (inslapen en doorslapen)
- Prikkelbaarheid en stemmingswisselingen
- Concentratieproblemen

- Gevoelens van angst en nervositeit
- Verminderde interesse in hobby's en sociale activiteiten

Psychologische Beoordeling

1. **Klinisch Interview**

- **Depressieve Symptomen**: John rapporteert gevoelens van verdriet, hopeloosheid, en verlies van interesse in dagelijkse activiteiten. Hij heeft geen suïcidale gedachten, maar geeft aan zich vaak overweldigd te voelen.
- **Angstsymptomen**: John ervaart regelmatig gevoelens van angst, vooral in stressvolle situaties op het werk. Deze gevoelens gaan gepaard met fysieke symptomen zoals hartkloppingen en zweten.
- **Stress en Coping**: John geeft aan dat hij moeite heeft met het hanteren van stress, wat leidt tot prikkelbaarheid en conflicten thuis en op het werk.

2. **Gestandaardiseerde Tests**

- **Beck Depression Inventory (BDI-II)**: John's score op de BDI-II wijst op een matige depressie.
- **State-Trait Anxiety Inventory (STAI)**: John's scores op zowel de 'state' als 'trait' angstschaal zijn verhoogd, wat duidt op aanzienlijke angst zowel in specifieke situaties als algemeen.
- **Perceived Stress Scale (PSS)**: John scoort hoog op de PSS, wat wijst op een hoge mate van ervaren stress.

3. **Zelfrapportage Vragenlijsten**

- **Burnout Assessment**: John vertoont verschillende kenmerken van burn-out, waaronder emotionele uitputting en cynisme ten opzichte van zijn werk.
- **Quality of Life (QoL)**: John's zelfbeoordeling van zijn kwaliteit van leven is laag, vooral op het gebied van werk en sociaal leven.

Diagnostische Overwegingen

Op basis van de verkregen gegevens komt John mogelijk in aanmerking voor de volgende diagnoses:

- **Major Depressive Disorder, moderate**: Gezien de duur en ernst van de depressieve symptomen.
- **Generalized Anxiety Disorder**: Gezien de aanhoudende en wijdverspreide angstgevoelens.
- **Adjustment Disorder with Anxiety and Depressed Mood**: Gezien de symptomen die lijken te worden uitgelokt door werkgerelateerde stress en familieomstandigheden.

Aanbevelingen

1. **Psychotherapie**

- **Cognitieve Gedragstherapie (CGT)**: Aanbevolen voor het aanpakken van negatieve denkpatronen en het ontwikkelen van effectieve copingmechanismen.
- **Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)**: Voor het verminderen van stress en het verbeteren van emotionele regulatie.

2. **Farmacotherapie**

- Overleg met een psychiater over de mogelijke voordelen van medicatie, zoals antidepressiva of anxiolytica, ter ondersteuning van de therapie.

3. **Levensstijl Aanpassingen**

- **Stressmanagement Technieken**: Aanleren van technieken zoals time-management en ontspanningsoefeningen.
- **Gezonde Slaapgewoonten**: Aanbevelingen voor het verbeteren van slaaphygiëne.
- **Lichaamsbeweging en Dieet**: Regelmatige lichaamsbeweging en een gebalanceerd dieet kunnen bijdragen aan een verbetering van de algehele mentale gezondheid.

4. **Ondersteuning en Educatie**

- Betrokkenheid van het gezin bij de behandeling om een ondersteunend thuisomgeving te creëren.
- Educatie over de aard van zijn aandoeningen en de verwachte behandelingstrajecten.

Conclusie

John Doe vertoont symptomen die wijzen op een combinatie van depressie, angst en stressgerelateerde problemen. Met een gerichte behandelingsaanpak, inclusief therapie, mogelijke medicatie en levensstijlveranderingen, is er een goede prognose voor verbetering van zijn psychologische welzijn.

Handtekening

Mark Jansen, MSc

Geregistreerd Klinisch Psycholoog